

Relacje karmią AN — izolacja, lęk społeczny, perfekcjonizm relacyjny

Trudności interpersonalne to czwarty mechanizm CBT-E enhanced. AN żywi się izolacją, lękiem społecznym, perfekcjonizmem w relacjach. Praca odwraca pętlę.

CZAS: moduł CBT-E enhanced lub równoległa IPT-ED — 8-12 sesji

REALIZACJA: gdy trudności interpersonalne to centralny mechanizm

ŹRÓDŁO: Rieger i in. (2010, IPT-ED model); Fairburn (2008, rozdz. 13); Wilfley i in. (2002, IPT dla BED)

JAK UŻYWAĆ

Sekcja 01 — **cztery typy trudności interpersonalnych** w AN (izolacja, lęk społeczny, perfekcjonizm relacyjny, brak asertywności). Sekcja 02 — **siedem kroków pracy** (CBT-E enhanced lub IPT-ED). Sekcja 03 — **arkusz „moje relacje”**.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Trudności interpersonalne (Rieger i in., 2010) — czwarty dodatkowy mechanizm podtrzymujący AN w modelu CBT-E enhanced (obok perfekcjonizmu, niskiej samooceny, niskiej tolerancji afektu). Cztery główne formy: **(1) izolacja społeczna** — wycofanie z relacji, samotność; **(2) lęk społeczny** — strach przed oceną, oblanie wzrokiem; **(3) perfekcjonizm relacyjny** — „nie mogę zawieść”, brak konfliktów, fasada; **(4) brak asertywności** — niezgłaszanie potrzeb, dostosowywanie się. **Pętla z AN:** trudności interpersonalne → emocjonalny dyskomfort → AN jako sposób regulacji / „kontrola czegoś” → wycofanie z relacji → jeszcze większa izolacja. IPT-ED (Interpersonal Psychotherapy for Eating Disorders) — alternatywa lub uzupełnienie CBT-E, koncentruje się **całkowicie** na relacjach jako głównym mechanizmie.

01 Cztery typy trudności interpersonalnych w AN

TYP

JAK SIĘ MANIFESTUJE

1 · Izolacja społeczna	Wycofanie z relacji, rezygnacja z aktywności społecznych, samotność. Często „nie mam siły” (głodzenie), „nie chcę, żeby widzieli mnie jeść”, „wstydzę się ciała”. AN żywi się izolacją.
2 · Lęk społeczny	Strach przed oceną wyglądu, jedzenia, zachowania. Unikanie restauracji, imprez, sytuacji jedzeniowych. Często komorbidność: SAD (lęk społeczny) — wymaga równoległej pracy.
3 · Perfekcjonizm relacyjny	„Nie mogę zawieść”, „nie mogę powiedzieć „nie””, „muszę być idealnym przyjacielem/-iółką”. Brak konfliktów, fasada, zmęczenie relacjami. Powierzchowne więzi mimo wielu kontaktów.
4 · Brak asertywności	Niezgłaszanie potrzeb, dostosowywanie się, milczenie w konflikcie. Lęk przed odrzuceniem. Pacjent „znika” w relacji — to wzmacnia poczucie pustki, którą AN „wypełnia”.

Pętla z AN: izolacja → samotność → AN jako „towarzysz” → jeszcze większa izolacja. Wielu pacjentów opisuje AN jako „najlepszego przyjaciela” — bo realne relacje są trudne. Praca interpersonalna otwiera alternatywę: prawdziwe więzi.

02 ☉ Siedem kroków pracy (CBT-E enhanced / IPT-ED)

1. **Psychoedukacja** — „AN żywi się trudnościami w relacjach. Im bardziej jesteś sam/-a, tym bardziej AN ma miejsca. Praca nad relacjami nie jest „dodatkiem” — jest kluczowa dla zdrowienia”.
2. **Obraz relacji** — pacjent rysuje „obraz relacji” — kto jest w jego życiu, jak blisko, jak często kontakt. Kategorie: bliscy, znajomi, koledzy/koleżanki, „powierzchowne”. Często mapa jest pusta — to dane.
3. **Identyfikacja problemu interpersonalnego** — IPT-ED: cztery główne typy problemów: *żał po stracie, konflikt, zmiana roli* (np. wyprowadzka, ślub, rozwód), *deficyty interpersonalne*. Wybór JEDNEGO głównego problemu na 8–12 sesji.
4. **Konkretne umiejętności** — w zależności od deficytu: nawiązywanie kontaktu, rozpoczynanie rozmów, wyrażanie potrzeb, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, tolerancja innej opinii.
5. **Eksperymenty behawioralne** — pacjent celowo wystawia się na sytuacje społeczne, które unika: zaprasza znajomego na kawę, mówi „nie” gdy nie chce, wyraża potrzebę. Bez doświadczenia — uczenia się nie ma.
6. **Praca z lękiem społecznym** — równoległe praca z myślami o ocenie („oni mnie ocenią”, „powiedzą, że jestem...”). Hierarchia ekspozycji, restrukturyzacja poznawcza.
7. **Sieć wsparcia długoterminowo** — celem nie jest „wiele znajomych”, lecz kilka głębokich relacji + sieć codziennego kontaktu. Grupa terapeutyczna, klub, wolontariat — sposoby budowania sieci.

03 Moja mapa relacji — arkusz

OSOBY BLISKIE W MOIM ŻYCIU

— imiona, jakim jestem dla nich, jak często kontakt; bądź szczerzy/-a — jeśli pusto, to też dane

GŁÓWNY PROBLEM INTERPERSONALNY W MOIM ŻYCIU

— *żał po stracie, konflikt z X, zmiana roli, deficyt umiejętności społecznych*

TRZY UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE, W KTÓRYCH CHCĘ SIĘ ROZWINĄĆ

— np. mówienie „nie”, wyrażanie potrzeb, rozpoczynanie rozmów, rozwiązywanie konfliktów

KONKRETNY EKSPERYMENT W TYM TYGODNIU

— np. zaproszę X na kawę; powiem „nie” Y; powiem o swojej potrzebie Z

Klucz: trudności interpersonalne są *najczęściej pomijanym* mechanizmem AN — bo terapia skupia się na jedzeniu, ciele, poznawczości. Tymczasem AN żywi się izolacją: im bardziej pacjent sam/-a, tym mocniej AN. **Komunikat dla pacjenta:** „nie chodzi o to, żebyś miał/-a „dużo znajomych” — chodzi o to, żebyś miał/-a kilka relacji, w których możesz być sobą, wyrażać potrzeby, słyszeć „dobrze, że jesteś”. Te relacje są długoterminową profilaktyką nawrotu. AN traci na sile, kiedy masz prawdziwych ludzi”.

⚠ **Lęk społeczny jako komorbidność:** u znaczącej części pacjentów z AN współlistnieje SAD (lęk społeczny). To nie jest sam objaw głodzenia — często poprzedza AN o lata. Wymaga równoległej pracy: ekspozycja na sytuacje społeczne, restrukturyzacja poznawcza myśli o ocenie. W skrajnych przypadkach — farmakoterapia (SSRI po stabilizacji wagi).